

HOMBRO CONGELADO O CAPSULITIS ADHESIVA

Jésica Rodríguez Álvarez, Javier Sánchez Palacios, José Ramón García Zarza, María Soledad Medina Martos.

INTRODUCCIÓN

Inflamación fibrosante de la articulación glenohumeral que produce una limitación del balance articular de forma activa y característicamente de forma pasiva. Es típica de mujeres en torno a los 50-60 años. Tiene una prevalencia de entre el 2-5%. Consta de tres fases: una primera fase que se caracteriza por dolor, una segunda fase que se caracteriza por rigidez y una tercera en la que se produce la resolución.

Clasificación:

- Primaria: no se encuentra ningún factor que incite la aparición de la misma.
- Secundaria: en casos de rigidez postraumática, asociada a DM o alteraciones tiroideas, traumatismos, entre otras.

DIAGNÓSTICO

Clínico basado en la exploración física

Exploración Física:

- Omalgia de características inflamatorias que no cede con el reposo.
- Alodinia o dolor por estimulación táctil que en condiciones normales no debería ser dolorosa.
- Limitación de todos los ejes del movimiento especialmente en la rotación externa tanto de forma activa como de forma pasiva, presentando en ésta última un tope característico. Esto es muy importante ya que nos permite diferenciarlo de otras patologías frecuentes del hombro como por ejemplo pudiera ser una rotura del manguito rotador.

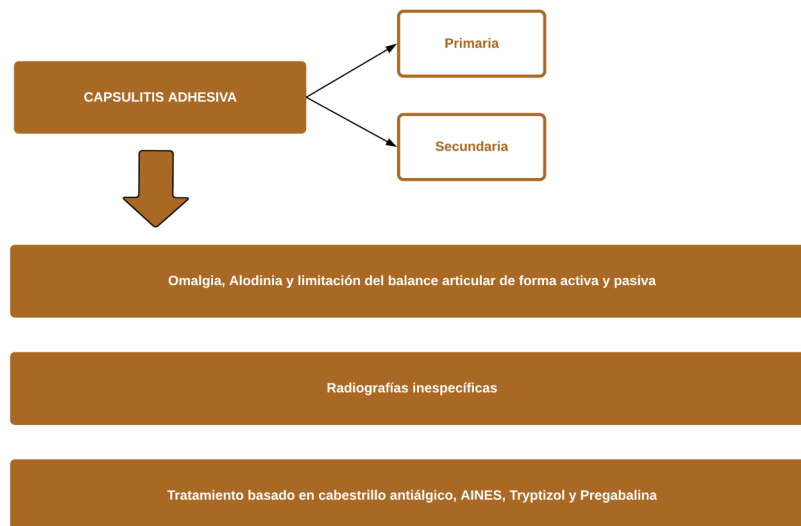
Se debe hacer un **diagnóstico diferencial** con el hombro rígido postraumático en el cual también existe una limitación con mayor afectación en la rotación interna

Pruebas Complementarias:

- Radiografía de hombro: es típicamente normal, pudiéndose observar en algunos casos desmineralización ósea.

TRATAMIENTO

- Colocación de cabestrillo antiálgico, evitando así la inmovilización del mismo.
- AINES según patología adyacente del paciente.
- Tryptizol 50mg preferentemente antes de acostarse, pudiendo aumentar dosis hasta 150mg/día.
- Pregabalina.
- Derivación al servicio de rehabilitación de forma preferente.



BIBLIOGRAFÍA

- Chassunot et Quesnot. Rehabilitación del miembro superior. España: editorial Panamericana, 2010.
- Serrano AM, Abush S. Capsulitis Adhesiva. Anales médicos. 2017; Vol. 62(1): 37-43.
- Dudkiewicz I, Oran A, Salai M, Palti R, Pritsch M. Idiopathic adhesive capsulitis: longterm results of conservative treatment. Isr Med Assoc J. 2004; 6: 524-526.